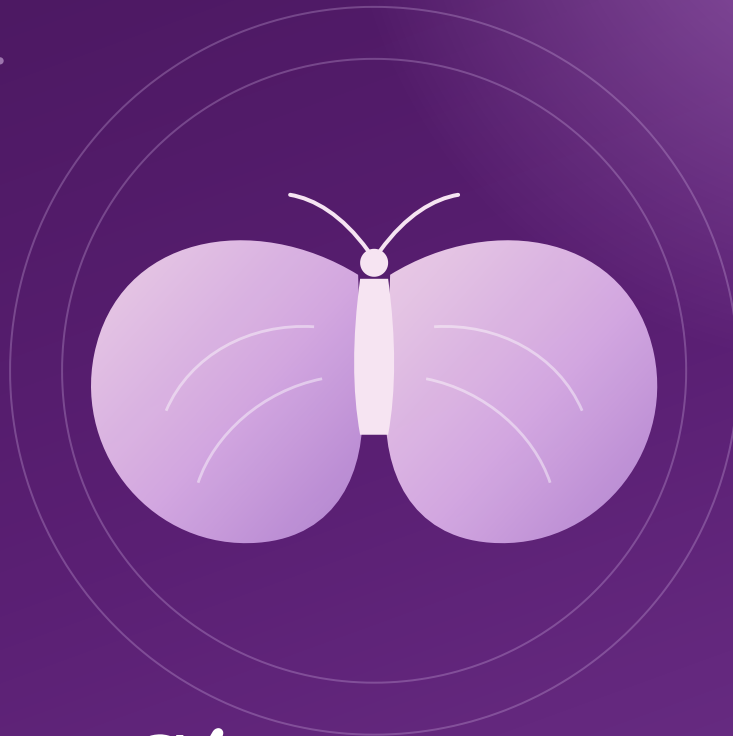


FELIZ SIN TIROIDES



¿Cómo tomar la levotiroxina *correctamente?*

Una guía ilustrada, basada en evidencia, para que cada microgramo de tu tratamiento llegue a donde tiene que llegar.

CHECKLIST · 12 ERRORES

LISTA DE SUPLEMENTOS

Tu tratamiento no falla: falla el momento.

Si tomas levotiroxina y aun así te sientes cansada, con frío, con el cabello quebradizo o con una TSH que "no se acomoda", antes de pensar en subir la dosis vale la pena revisar **cómo y cuándo** la estás tomando.

La levotiroxina es un medicamento de **margen terapéutico estrecho**: se dosifica en microgramos, por lo que pequeñas interferencias en la fase de absorción se vuelven clínicamente significativas.

La buena noticia es que casi todas esas interferencias se corrigen con una sola herramienta: el reloj.

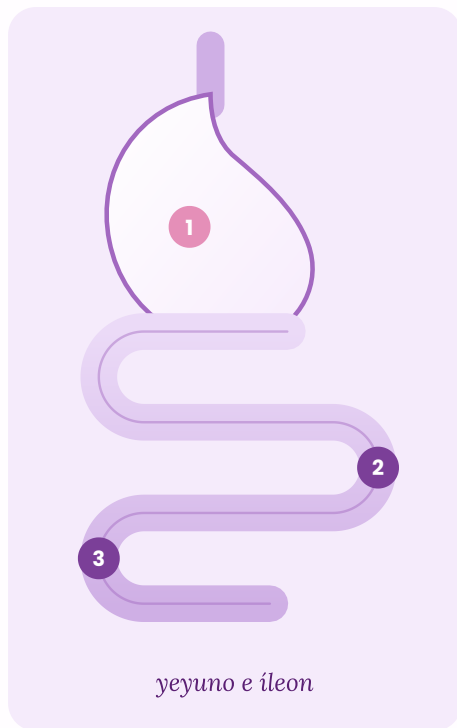
LO QUE ENCONTRARÁS

- | | | |
|----|--|----|
| 01 | Cómo viaja tu levotiroxina
Dónde se absorbe, cuánto y en qué ventana de tiempo | 03 |
| 02 | La regla de oro del horario
Mañana o noche: qué dice la evidencia | 04 |
| 03 | Tu línea de tiempo perfecta
Minuto a minuto, desde que abres los ojos | 05 |
| 04 | Checklist: 12 errores frecuentes
Para imprimir, marcar y corregir | 06 |
| 05 | Lista de suplementos
Semáforo de separación horaria | 08 |
| 06 | Mi plan personal
Rutina y registro de 7 días | 09 |

Importante. Este material es educativo y no reemplaza la consulta con tu médico ni con tu químico farmacéutico. **Nunca modifiques tu dosis por tu cuenta.** Si cambias tus horarios o tus suplementos, coméntalo en tu control y solicita una nueva TSH.

Cómo viaja tu levotiroxina

La tableta no actúa en el estómago: primero debe disolverse y luego cruzar la pared del intestino delgado. Todo lo que ocurra en ese trayecto cuenta.



1 · ESTÓMAGO

La tableta se **disgrega y se disuelve** gracias a la acidez gástrica. Si el pH del estómago sube (antiácidos, inhibidores de bomba de protones, gastritis atrófica, infección por *H. pylori*), este primer paso se ve comprometido.

2 · YEYUNO

Aquí ocurre la mayor parte de la absorción. Cualquier sustancia que **se adhiera a la levotiroxina** o forme complejos insolubles (calcio, hierro, fibra, café) reduce la cantidad disponible.

3 · ÍLEON

Se completa el proceso. Enfermedades intestinales como la **celiaquía** o la **intolerancia a la lactosa** pueden disminuir la absorción sin que tú hagas nada mal.

60–82%

de la dosis se absorbe en condiciones ideales

3 h

ventana en la que ocurre casi toda la absorción

~7 días

vida media: por eso una toma aislada no arruina todo

4–8 sem

tiempo para recontrolar la TSH tras un cambio

CONDICIONES DIGESTIVAS QUE TAMBIÉN REDUCEN LA ABSORCIÓN

Enfermedad celíaca

Gastritis atrófica

Infección por *H. pylori*

Intolerancia a la lactosa

Síndrome de intestino corto

Traducción práctica: lo que decides en los primeros 60 minutos después de tomar tu tableta, y lo que tomas en las 4 horas siguientes, define cuánta hormona entra realmente a tu cuerpo. No es obsesión: es farmacocinética.

La regla de oro del horario

Las guías de la American Thyroid Association reconocen dos momentos válidos. El mejor es el que puedas sostener **todos los días**, siempre igual.



Opción A · En ayunas

30 a 60 minutos antes del desayuno, con un vaso de agua sola.

- Es el esquema clásico y el más estudiado.
- Requiere disciplina con el café y el desayuno.
- Ideal si te levantas y te alistas con calma.



Opción B · Al acostarte

Mínimo 3 horas después de la última comida del día.

- Un ensayo clínico aleatorizado cruzado y doble ciego mostró una TSH significativamente menor con la toma nocturna.
- Útil si tus mañanas son caóticas o no puedes esperar para el café.
- Exige cenar temprano y no picar después.

LO QUE NO CAMBIA, ELIJAS LA QUE ELIJAS

Siempre a la misma hora. La constancia pesa más que la hora exacta que escojas.

Solo con agua. No con jugo, leche, café, té ni aromática.

Estómago vacío. Nada de comida en la ventana acordada.

Sin cambiar sola. Si cambias de horario, pide TSH a las 4-8 semanas.

ELIGE LA TUYA EN TRES PREGUNTAS

01 ¿Puedes esperar una hora antes de tu primer café?

02 ¿Sueles cenar al menos tres horas antes de dormir?

03 ¿Cuál de las dos vas a cumplir también el domingo?

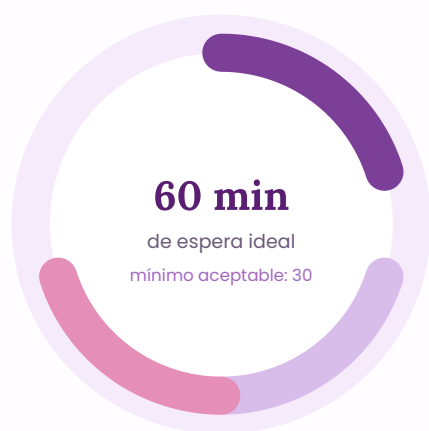
La respuesta correcta es la que sostienes. Una toma nocturna bien hecha rinde más que una matutina que siempre termina acompañada del desayuno.

¿Y si un día se me olvida?

Gracias a su vida media prolongada, un olvido aislado no desestabiliza tu tratamiento. Tómala en cuanto lo recuerdes, siempre que puedas respetar el estómago vacío; si ya es casi la hora de la siguiente dosis, continúa con tu horario habitual. **Nunca dupliques la dosis por tu cuenta:** consulta antes con tu médico o tu químico farmacéutico.

Tu línea de tiempo perfecta

Este es el esquema de la toma matutina. Si eliges la toma nocturna, la lógica es la misma: 3 horas sin comer antes, y los suplementos con minerales lejos de la tableta.



0 min
AL DESPERTAR

Tu tableta y un vaso de agua

Agua a temperatura ambiente, un vaso completo. Trágala entera, sin masticar ni disolver, salvo indicación expresa de tu médico.

0-60 min
ZONA CRÍTICA

Nada más que agua

Sin café, sin té, sin leche, sin jugo, sin desayuno y sin otros medicamentos. Aprovecha para bañarte, alistarte o caminar.

60 min
VÍA LIBRE

Desayuna y toma tu café

También puedes tomar los medicamentos que no interfieren y las vitaminas **sin minerales**.

+4 horas
SEPARACIÓN

Calcio, hierro, magnesio y antiácidos

Llévalos al almuerzo o a la cena. Cuatro horas de distancia es la recomendación habitual para evitar que formen complejos con la levotiroxina.

SI ELEGISTE LA TOMA NOCTURNA



TRUCOS QUE SÍ FUNCIONAN

El vaso de la noche

anterior. Deja el agua y la tableta en tu mesa de noche: se toma antes de levantarte.

Alarma con nombre.

Programa "mi tiroides" a la misma hora todos los días, incluidos fines de semana.

Pastillero semanal.

Evita la duda de "¿ya me la tomé?" y hace visible el olvido.

Ancla a un hábito.

Únela a algo que ya haces sin falta, como apagar el despertador.

Cumplir la ventana de espera es la forma más barata de mejorar tu tratamiento.

12 errores que pueden alterar la absorción de tu levotiroxina

Marca con honestidad los que reconozcas en tu rutina. No es una lista para sentir culpa: es un mapa para encontrar exactamente qué ajustar esta semana.

1

Desayunar de inmediato después de tomarla

Los alimentos reducen de forma significativa la biodisponibilidad de la levotiroxina. **Corrección:** espera de 30 a 60 minutos, idealmente 60.

☐

2

Pasarla con café, tinto o té

El café tomado junto con la tableta reduce y retrasa la absorción intestinal de la hormona. **Corrección:** el café va después de la ventana de espera, nunca con la tableta.

☐

3

Tomarla con leche, yogur o bebidas lácteas

El calcio de los lácteos forma complejos poco solubles con la levotiroxina. **Corrección:** solo agua; los lácteos entran con el desayuno, después de la espera.

☐

4

Tomar calcio en la misma toma

Carbonato o citrato de calcio, solos o dentro de un multivitamínico, reducen la absorción de manera clínicamente relevante. **Corrección:** sepáralos al menos 4 horas.

☐

5

Tomar hierro junto con la levotiroxina

El sulfato ferroso y otras sales de hierro forman complejos que disminuyen la cantidad de hormona disponible. **Corrección:** sepáralos al menos 4 horas; muchas mujeres lo llevan al almuerzo.

☐

6

Usar antiácidos con aluminio o magnesio a la misma hora

Adsorben la levotiroxina en el tubo digestivo y elevan el pH gástrico, comprometiendo la disolución de la tableta. **Corrección:** al menos 4 horas de distancia.

☐

Cómo usar esta lista. Escoge **solo dos** casillas marcadas y corrígelas durante las próximas cuatro semanas. Anótalo en tu plan de la página 9 y llévalo a tu próximo control junto con tu TSH.

Los seis que casi nadie tiene en el radar

7

Empezar omeprazol u otro protector gástrico sin avisar

☐

Los inhibidores de la bomba de protones elevan el pH del estómago y se han asociado con aumento de la TSH en pacientes tratados con levotiroxina. **Corrección: infórmalo en tu control y pide una TSH de seguimiento.**

8

Fibra, salvado o psyllium en la misma ventana

☐

Las dietas enriquecidas en fibra y los suplementos de fibra soluble se han asociado con menor biodisponibilidad. **Corrección: llévalos a otro momento del día y mantén la fibra estable, no a saltos.**

9

Soya cerca de la toma

☐

Leche de soya, proteína de soya y fórmulas con soya se han relacionado con TSH más altas y mayor requerimiento de dosis. **Corrección: sepárala de la toma y avisa si la consumes a diario.**

10

Pasarla con jugos en lugar de agua

☐

Se han reportado alteraciones de la eficacia con jugos como el de papaya y con otras bebidas, aunque la evidencia todavía es limitada. **Corrección: agua sola, siempre. Es la opción sin discusión.**

11

Cenar tarde y tomarla igual "de noche"

☐

La toma nocturna solo funciona si respetas el ayuno. Si cenaste hace una hora, estás tomándola con comida. **Corrección: mínimo 3 horas después de la última comida, sin picar después.**

12

Cambiar de marca, presentación u horario sin recontrolar

☐

Las distintas formulaciones y los cambios de rutina pueden modificar la absorción; la dosis correcta de ayer puede no serlo hoy. **Corrección: ante cualquier cambio, solicita TSH a las 4–8 semanas.**

CUANDO EL PROBLEMA NO ERES TÚ

Si haces todo bien y tu TSH sigue inestable, existen causas digestivas que dificultan la absorción y que deben descartarse en consulta: **enfermedad celíaca, gastritis atrófica, infección por *Helicobacter pylori* e intolerancia a la lactosa.** Llevar este checklist ya diligenciado le ahorra tiempo a tu médico y hace que la conversación empiece en el punto correcto.

Lista de suplementos y su semáforo de separación

Ningún suplemento de esta lista está prohibido. Lo que cambia es **a qué hora lo tomas**.



Separa mínimo 4 horas

INTERACCIÓN DOCUMENTADA

Calcio (carbonato)

Calcio (citrato)

Hierro / sulfato ferroso

Multivitamínicos con minerales

Antiácidos con aluminio

Magnesio

Quelantes de fósforo

Secuestradores de ácidos biliares

Carbonato de lantano



Precaución y consulta

EVIDENCIA LIMITADA O EFECTO SOBRE LA TIROIDES

Fibra y psyllium

Isoflavonas de soya

Cromo

Yodo / kelp / algas

Zinc

Proteína en polvo con minerales

El yodo y las algas no bloquean la absorción, pero pueden alterar el funcionamiento de la glándula. En tiroiditis de Hashimoto, no los tomes por iniciativa propia.



Sin interacción de absorción demostrada

AUN ASÍ, SEPÁRALOS POR PRUDENCIA

Vitamina D

Vitamina B12

Omega 3

Vitamina C

Complejo B sin minerales

Probióticos

Se ha descrito que la vitamina C podría incluso favorecer la absorción de la levotiroxina, pero el hallazgo aún necesita estudios más amplios antes de convertirse en una recomendación.

Alerta especial: la biotina

La biotina, presente en casi todos los suplementos para cabello, piel y uñas, **no altera la absorción** de tu levotiroxina, pero sí puede **falsear los resultados de tus exámenes**. Interfiere con los inmunoensayos que usan biotina y estreptavidina, y puede producir una TSH falsamente baja o una T4 libre falsamente alta, un cuadro que se confunde con hipertiroidismo. Pregunta en tu laboratorio cuántas horas debes suspenderla antes de la toma de muestra y avisa siempre a tu médico que la estás tomando.

Mi plan personal

Escríbelo. Un plan en papel se cumple mucho más que un propósito mental.

MI RUTINA

Tomo mi levotiroxina a las

Desayuno o rompo el ayuno a las

Mis suplementos con minerales
quedan a las

Mi dosis actual es de

Fecha de mi próximo control de TSH

LOS DOS ERRORES QUE VOY A CORREGIR

ERROR NÚMERO

ERROR NÚMERO

MI REGISTRO DE 7 DÍAS

DÍA	HORA DE LA TOMA	SOLO CON AGUA	ESPERÉ 30-60 MIN	SEPARÉ MINERALES	CÓMO ME SENTÍ
Lunes		☐	☐	☐	
Martes		☐	☐	☐	
Miércoles		☐	☐	☐	
Jueves		☐	☐	☐	
Viernes		☐	☐	☐	
Sábado		☐	☐	☐	
Domingo		☐	☐	☐	

No estás haciendo nada mal por necesitar una tableta todos los días. Estás cuidando, con precisión, un órgano que trabaja para ti a cada minuto.

Referencias

Todo lo que leíste en esta guía procede de las siguientes fuentes, citadas en formato Vancouver.

1. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, Burman KD, Cappola AR, Celi FS, et al. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. *Thyroid*. 2014;24(12):1670–751. doi: <https://doi.org/10.1089/thy.2014.0028>
2. Skelin M, Lucijanić T, Amidžić Klarić D, Rešić A, Bakula M, Liberati-Čizmek AM, et al. Factors Affecting Gastrointestinal Absorption of Levothyroxine: A Review. *Clin Ther*. 2017;39(2):378–403. doi: <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2017.01.005> · PMID: 28153426 · <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28153426/>
3. Wiesner A, Gajewska D, Paško P. Levothyroxine Interactions with Food and Dietary Supplements—A Systematic Review. *Pharmaceuticals (Basel)*. 2021;14(3):206. doi: <https://doi.org/10.3390/ph14030206> · PMID: 33801406 · <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33801406/>
4. Liu H, Lu M, Hu J, Fu G, Feng Q, Sun S, et al. Medications and Food Interfering with the Bioavailability of Levothyroxine: A Systematic Review. *Ther Clin Risk Manag*. 2023;19:503–23. doi: <https://doi.org/10.2147/TCRM.S414460> · PMID: 37384019 · <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37384019/>
5. Bolk N, Visser TJ, Nijman J, Jongste IJ, Tijssen JGP, Berghout A. Effects of evening vs morning levothyroxine intake: a randomized double-blind crossover trial. *Arch Intern Med*. 2010;170(22):1996–2003. doi: <https://doi.org/10.1001/archinternmed.2010.436> · PMID: 21149757 · <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21149757/>
6. Benvenga S, Bartolone L, Pappalardo MA, Russo A, Lapa D, Giorgianni G, et al. Altered intestinal absorption of L-thyroxine caused by coffee. *Thyroid*. 2008;18(3):293–301. doi: <https://doi.org/10.1089/thy.2007.0222> · PMID: 18341376 · <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18341376/>
7. Favresse J, Burlacu MC, Maiter D, Gruson D. Interferences With Thyroid Function Immunoassays: Clinical Implications and Detection Algorithm. *Endocr Rev*. 2018;39(5):830–50. doi: <https://doi.org/10.1210/er.2018-00119> · PMID: 29982406 · <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29982406/>

Aviso. Esta guía tiene fines exclusivamente educativos y no constituye una consulta médica ni farmacéutica individual. Las recomendaciones de separación horaria son generales y pueden variar según tu formulación, tus otros medicamentos y tus condiciones de salud. **No suspendas, aumentes ni disminuyas tu dosis de levotiroxina sin indicación de tu médico tratante.**



Feliz Sin Tiroides

EDUCACIÓN EN SALUD TIROIDEA